

CHE

Laparoskopische Cholecystektomie

In medizinisch begründeten Fällen kann bzw. muss von der vereinbarten SOP abgewichen werden. Diese Abweichung ist jedenfalls zu dokumentieren.

Präoperative Untersuchungen :

Obligat :

- Anamnese + Status
- Aufnahmelabor (Chirmed, Blutgruppe, Antikörpersuchtest)
- Abdomensonographie
- Anästhesiebegutachtung

Fakultativ :

- MRCP oder ERCP (bei pathologischen Leberwerten/Cholestase oder sonographischen Verdacht auf Gallengangspathologie)
- Thorax-Röntgen (Indikation siehe unter präop. Diagnostik)
- internistische Vorstellung (Indikation siehe unter präop. Diagnostik)

Präoperative Maßnahmen :

- Standard-Antibiose bei akuter Cholezystitis falls keine Kontraindikation vorliegt, ist Unasyn 3x 3g i.v. bzw. Dosisadaptierung je nach Nierenfunktionsparametern. Bei schwerer Cholangitis Piperazilin/Tazobactam 3x4,5g iv

Intraoperativ :

- Keine routinemäßige intraoperative Cholangiographie (wird nur selektiv durchgeführt).
- Kein routinemäßiges Legen einer Drainage (wird selektiv je nach intraoperativem Befund durch den Operateur indiziert).

Postoperativ:

- Thromboseprophylaxe mit niedermolekularem Heparin wie z.B. Lovenox falls keine Kontraindikation vorliegt und je nach allgemeiner Risikosituation 6 Stunden postoperativ.

Am OP-Tag :

- 500ml RL/Elomel + 1Amp.Diclofenac, Novalgin, Paracetamol oder Buscopan. Weitere Adaptierung je nach Schmerzsituation.
- Im Falle einer akuten Cholezystitis ggf. Antibiose

Am Abend:

- Tee
- Mobilisierung

1. postoperativer Tag :

- erweiterte Mobilisierung
- Normalkost
- ggf. Analgetika p.o. oder i.v. je nach Schmerzensituation
- Drainentfernung je nach Fördermenge (nach ärztlicher Anordnung)
- Laborkontrolle (BB,CRP, LFP, Bili, Alkalische Phosphatase, Elyte, NFP)

2. postoperativer Tag :

- ggf. Analgetika p.o. oder i.v. je nach Schmerzensituation
- ggf. Stuhlregulierende Maßnahmen (Molaxole, Agaffin, Klysmol)
- Verbandswechsel

Entlassung:

- 2. bis 5.postoperativer Tag, je nach postoperativem Verlauf
- Falls keine Intrautannähte, Nahtentfernung am 7.postoperativem Tag, vorzugsweise beim Hausarzt.

Empfohlene postoperative Maßnahmen:

- Körperliche Schonung und fettreduzierte Diät für 2 – 3 Wochen.
- Keine routinemäßigen Kontrollen in der chirurgischen Ambulanz. Kontrollen beim Hausarzt.

Spezielle Situationen in der Gallenchirurgie:
offene Cholecystektomie / Gallengangsrevision

Eine primär offene Cholecystektomie bzw. ein Umstieg von einer laparoskopischen zur offenen Cholecystektomie wird meist bei einem komplizierten Gallensteinleiden durchgeführt, entsprechend kann sich das postoperative Vorgehen von dem nach laparoskopischer Cholezystektomie unterscheiden:

- evt. längere Infusions- und Schmerztherapie
- längere Gabe eines Antibiotikums
- mehrfache Laborkontrollen
- verzögerter Kostaufbau
- längere Liegedauer des Drains

Vorgehen bei liegendem T-Drain (durchgeführter Gallengangsrevision):

- T Drain und Zieldrainage vorerst 7 Tage belassen.
- Am 7. Tag Durchführung einer T-Drain Cholangiographie: Bei unauffälligem Gallengang und ungestörtem Abfluß ins Duodenum wird das T-Drain entfernt.
- Die Zieldrainage wird noch für einen Tag belassen und am nächsten Tag (8.Tag) bei unauffälliger Fördermenge entfernt.